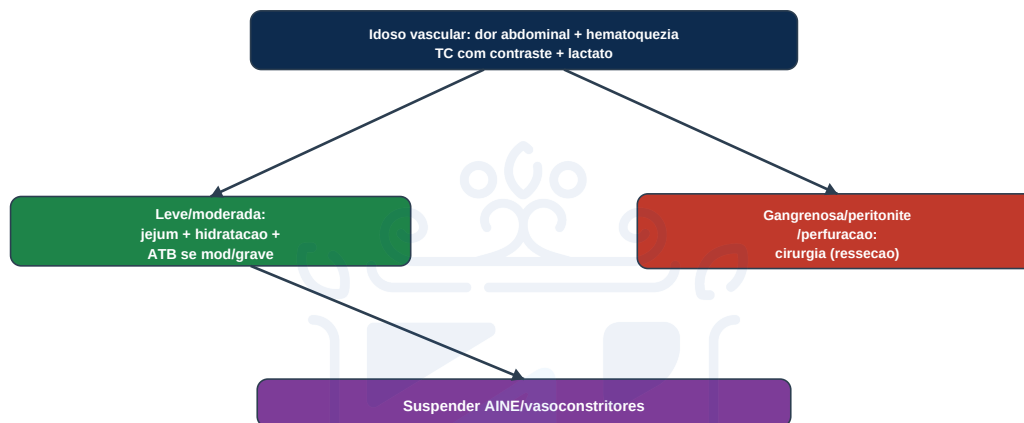


COLITE ISQUÊMICA — IDOSO + HEMATOQUEZIA

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

COLITE ISQUÊMICA — SUPORTE x CIRURGIA



DEFINIÇÃO E CLÍNICA

O QUE É

- Redução do fluxo sanguíneo ao cólon -> inflamação, lesão de mucosa e, potencialmente, necrose transmural com perfuração/seps
- Mais comum em IDOSOS com fatores vasculares e hipoperfusão sistêmica
- Clínica: dor em cólica (tipicamente no quadrante inferior ESQUERDO), HEMATOQUEZIA, diarreia com muco/sangue, distensão, febre baixa
- Fatores de risco: idade avançada, aterosclerose/arritmia, hipotensão/choque, vasoconstritores
- Sinais de peritonite (dor intensa, rigidez) sugerem forma complicada/gangrenosa

DIAGNÓSTICO

LABORATÓRIO + IMAGEM

- Laboratório: hemograma (leucocitose, anemia), PCR/VHS, função renal e eletrólitos, LACTATO (perfusão)
- TC de abdome com contraste: exame inicial de escolha — espessamento mural do cólon, exclui complicações (pneumoperitônio, ar na parede)
- Colonoscopia/sigmoidoscopia: confirma e biopsia — indicada quando o paciente está ESTÁVEL
- Diferenciar de isquemia mesentérica aguda (intestino delgado, dor desproporcional, mais grave)
- Não retardar a avaliação cirúrgica se houver sinais de peritonite/instabilidade

CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE

Nível	Crítérios-chave
Leve / moderada	Hemodinâmica estável, sem peritonite, hematoquezia leve
Severa	Leucocitose alta, dor persistente, instabilidade hemodinâmica
Gangrenosa / complicada	Perfuração, pneumoperitônio, peritonite franca -> cirurgia imediata

TRATAMENTO

Rx SUPORTE + ATB + ANALGESIA

Suporte: jejum (NPO) nas primeiras 24-72h, hidratação EV com cristaloide, O2 se SatO2 < 94%
SUSPENDER AINES e vasoconstritores; profilaxia de TVP conforme risco hemorrágico
ATB (casos moderados a graves, por translocação bacteriana): Pipe-tazo 3,375-4,5 g EV 6-8/8h; ou Ceftriaxona 1-2 g/dia + Metronidazol 500 mg 8/8h
Alergia à penicilina: Ciprofloxacino 400 mg EV 12/12h + Metronidazol 500 mg 8/8h; duração 5-10 dias
Analgesia: Dipirona 500-1000 mg 6-8/8h; opioide (Morfina 2-4 mg) com cautela (monitorar peritonite/motilidade)
Nutrição progressiva (líquida -> regular) conforme melhora; parenteral se jejum > 5-7 dias

UTI / CIRURGIA

QUANDO ESCALAR

- UTI: instabilidade hemodinâmica, acidose persistente, choque, insuficiência respiratória
- INDICAÇÃO CIRÚRGICA: perfuração com pneumoperitônio, peritonite franca, necrose transmural evidente, deterioração progressiva
- Cirurgia: ressecção do segmento acometido com anastomose ou colostomia, conforme avaliação
- Monitorizar sinais vitais 4-6/6h; hemograma e eletrólitos diários; vigiar piora (febre persistente, peritonite)
- Critério cirúrgico imediato: peritonite, perfuração, instabilidade progressiva

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos, fatores vasculares ____, com dor abdominal + hematoquezia; peritonite ____.
- Sinais vitais ____; lactato ____; TC: espessamento mural ____, pneumoperitônio/ar na parede ____; gravidade ____.
- Condutas: jejum, hidratação, suspensão de AINE/vasoconstritor, ATB ____, analgesia.
- Solicito UTI/cirurgia se instabilidade/peritonite/perfuração; transporte com monitorização e O2.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a apresentação típica da colite isquêmica?

- A) Jovem com dor periumbilical e diarreia aquosa
- B) Idoso com fatores vasculares, dor abdominal (quadrante inferior esquerdo) e hematoquezia
- C) Criança com vômitos biliosos
- D) Adulto com icterícia e colúria
- E) Gestante com dor pélvica

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual exame de imagem é a escolha inicial na suspeita de colite isquêmica?

- A) Colonoscopia de urgência em todos
- B) Tomografia de abdome com contraste
- C) Enema opaco
- D) Radiografia de tórax
- E) Cintilografia

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual medida de suporte é importante na colite isquêmica?

- A) Manter vasoconstritores
- B) Suspender AINEs e vasoconstritores, com jejum e hidratação EV
- C) Iniciar AINE de rotina
- D) Restrição hídrica agressiva
- E) Alta precoce com dieta livre

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é a indicação de cirurgia na colite isquêmica?

- A) Hematoquezia leve isolada
- B) Perfuração, peritonite franca ou necrose transmural evidente
- C) Dor controlada com analgesia oral
- D) Hemodinâmica estável
- E) Dieta tolerada

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual marcador laboratorial é útil para avaliar a perfusão/gravidade na colite isquêmica?

- A) Bilirrubina
- B) Lactato
- C) Amilase
- D) TSH
- E) Troponina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A colite isquêmica é típica de idosos com fatores vasculares, manifestando-se com dor abdominal (geralmente no quadrante inferior esquerdo) e hematoquezia, após episódios de hipoperfusão.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A TC de abdome com contraste é a escolha inicial: mostra espessamento mural do cólon e exclui complicações (pneumoperitônio, ar na parede). A colonoscopia confirma quando o paciente está estável.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

É importante suspender AINEs e vasoconstritores, manter jejum nas primeiras 24-72h e hidratação EV, além de antibiótico nos casos moderados/graves.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A cirurgia é indicada na presença de perfuração, peritonite franca ou necrose transmural evidente (forma gangrenosa/complicada) ou deterioração progressiva.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O lactato é marcador de hipoperfusão/gravidade na colite isquêmica, auxiliando a identificar isquemia significativa e a necessidade de escalonamento.

SM24
Suporte ao Plantão Médico